

CAPÍTULO 13.3

COVID-19

PERFIL EUNACOM 1.13.03

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO)** es una de las causas más frecuentes de consulta en los servicios de urgencia y atención primaria durante los meses de invierno en Chile. Se define como un cuadro clínico caracterizado por inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias bajas en niños, generalmente de origen infeccioso.

Definiciones Clave y Diferenciación

Es fundamental distinguir entre los diferentes términos clínicos que suelen confundirse en la práctica diaria:

TABLA 13.3.1: TÉRMINO VS DEFINICIÓN

TÉRMINO	DEFINICIÓN	EDAD TÍPICA
Bronquiolitis	Primer episodio de SBO en el lactante.	< 1 - 2 años
SBO (Agudo)	Cuadro agudo de obstrucción bronquial (sinónimo de crisis obstructiva).	Lactantes y preescolares
SBO Recurrente (SBOR)	3 o más episodios de SBO en un periodo de 12 meses.	< 2 años
Asma	Obstrucción bronquial recurrente con alta probabilidad de cronicidad.	> 2 - 6 años

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del inicio del cuadro: La mayoría de los cuadros de SBO comienzan como una infección respiratoria alta. Los virus (como el **VRS**) infectan inicialmente la vía aérea superior (nasofaringe), provocando rinorrea y fiebre. Posteriormente, el virus desciende hacia la vía aérea inferior, causando inflamación del epitelio bronquial, edema de la mucosa y aumento de secreciones, lo que genera la obstrucción característica.

Etiología: El rol de los virus

La causa principal del SBO es viral en la gran mayoría de los casos.

- **Virus Respiratorio Sincicial (VRS):** Es el agente más importante, responsable de aproximadamente el **80% de los casos**.
- **Metapneumovirus:** Ha emergido como la segunda causa más frecuente en Chile en los últimos años.
- **Otros virus:** Virus Para-influenza, Adenovirus, Influenza y Rinovirus.
- **Bacterias:** Aunque menos frecuentes, el *Mycoplasma pneumoniae* puede simular perfectamente una crisis obstructiva o un cuadro de asma, especialmente en niños mayores.

Cuadro Clínico: Pilares del Diagnóstico

El diagnóstico del SBO es **estrictamente clínico**. No se requieren exámenes de laboratorio o imágenes para confirmar la presencia del síndrome, aunque pueden ser útiles para descartar complicaciones (como neumonía).

La clínica se divide en dos grandes grupos de signos:

1. Signos de Obstrucción

Indican que el flujo de aire está dificultado por el estrechamiento de los bronquios: - **Sibilancias:** El signo más característico a la auscultación (y a veces audible a distancia). - **Roncus:** Por presencia de secreciones. - **Hiperinsuflación:** Aumento del diámetro anteroposterior del tórax ("tórax en tonel" funcional). - **Espiración prolongada.**

2. Signos de Dificultad Respiratoria

Indican el esfuerzo que realiza el paciente para compensar la obstrucción: - **Taquipnea:** Aumento de la frecuencia respiratoria (primer signo de alarma). - **Retracción de musculatura accesoria:** Puede ser subcostal, intercostal o tiraje cervical. - **Cianosis:** Signo de hipoxemia severa (tardío). - **Aleteo nasal.**

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perlas de Diagnóstico Diferencial: - Si el niño tiene **menos de 2 años** y es su primer episodio: **Bronquiolitis**. - Si el niño tiene **más de 2-6 años** y presenta episodios recurrentes: Sospechar **Asma**. - La mayoría de los niños con SBOR (recurrente) dejarán de tener síntomas al crecer; los niños con asma suelen persistir con síntomas a lo largo de su vida.

Evaluación de la Severidad: Score de Tal

Para objetivar la gravedad de la crisis y guiar el tratamiento, se utiliza el **Score de Tal**. Este score evalúa 4 parámetros clínicos:

- **Frecuencia Respiratoria** (ajustada por edad).
- **Sibilancias.**
- **Cianosis.**
- **Uso de musculatura accesoria** (retracción).

Cada parámetro se puntúa de 0 a 3. Un puntaje mayor indica mayor gravedad de la crisis.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Signos de Extrema Gravedad: Más allá del Score de Tal, existen signos que indican una falla respiratoria inminente o agotamiento, lo que requiere manejo de urgencia inmediata: - **Compromiso de conciencia:** Somnolencia, irritabilidad extrema o letargo. - **Agotamiento muscular:** El niño deja de hacer esfuerzo respiratorio porque ya no tiene energía (puede preceder al paro respiratorio). - **Silencio auscultatorio:** La obstrucción es tan severa que no pasa aire, por lo que dejan de escucharse sibilancias. - **Saturación de oxígeno baja:** Especialmente si no mejora con oxígeno suplementario.

Evolución hacia el Asma

Una de las grandes dudas en la práctica clínica es cuándo dejar de llamar a un niño "SBO Recurrente" y empezar a llamarlo "Asmático".

- **< 2 años:** La probabilidad de que sea asma es baja; la mayoría son "sibilantes transitorios".
- **2 a 3 años:** Es una zona gris donde el riesgo de asma empieza a aumentar según los antecedentes (atopia, herencia).
- **> 6 años:** Si hay obstrucción recurrente, el diagnóstico es **Asma** con alta certeza.

Es fundamental recordar que, independientemente del nombre del diagnóstico, el **manejo clínico inicial** de una crisis obstructiva en un paciente con SBOR o en uno con Asma es prácticamente el mismo (basado en broncodilatadores y corticoides según sea el caso).

- *Próximos temas recomendados:*
- **Manejo del SBO Agudo**
- **Score de Tal en detalle**
- **Oxigenoterapia en Pediatría**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 68 años, hipertenso, diabético y obeso, consulta por fiebre de 38.5°C, tos seca y disnea progresiva de 5 días de evolución. La saturación de oxígeno es 88% y la radiografía de tórax muestra infiltrados bilaterales. Se sospecha COVID-19. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para COVID-19. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19; no confundir con SARS-CoV-1
- El espectro clínico va desde asintomático hasta neumonitis viral con SARS
- El factor de riesgo más importante para gravedad es la edad avanzada
- Los factores de riesgo cardiovascular (HTA, obesidad, diabetes) aumentan el riesgo de evolución grave
- Tratamiento sintomático con paracetamol en casos leves; corticoides en neumonía grave
- Los corticoides han sido el fármaco que más ha disminuido la mortalidad en COVID-19 grave
- La heparina de bajo peso molecular se usa para prevenir complicaciones trombóticas
- PCR es el gold standard diagnóstico: sensibilidad ~90%, especificidad ~100%
- El test de antígeno tiene buena sensibilidad en sintomáticos pero baja en asintomáticos
- La TAC de tórax puede mostrar patrones característicos de COVID-19

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (COVID-19)**PREGUNTA 1**

Paciente de 68 años, hipertenso, diabético y obeso, consulta por fiebre de 38.5°C, tos seca y disnea progresiva de 5 días de evolución. La saturación de oxígeno es 88% y la radiografía de tórax muestra infiltrados bilaterales. Se sospecha COVID-19. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

- A)** Test de antígeno rápido
- B)** PCR para SARS-CoV-2
- C)** TAC de tórax
- D)** Radiografía de tórax
- E)** Serología IgG/IgM para SARS-CoV-2

PREGUNTA 2

Paciente de 72 años con COVID-19 confirmado por PCR, que evoluciona con neumonía bilateral grave y requerimiento de oxígeno suplementario. ¿Cuál de los siguientes fármacos ha demostrado mayor reducción de la mortalidad en estos pacientes?

- A)** Paracetamol
- B)** Heparina de bajo peso molecular
- C)** Corticoides
- D)** Antibióticos de amplio espectro
- E)** Broncodilatadores inhalados

PREGUNTA 3

Respecto al test de antígeno para SARS-CoV-2, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A)** Tiene mayor sensibilidad que la PCR en pacientes asintomáticos
- B)** Su especificidad es significativamente menor que la de la PCR
- C)** Tiene buena sensibilidad en pacientes sintomáticos, cercana a la de la PCR
- D)** Es el examen gold standard para el diagnóstico de COVID-19
- E)** No es útil en ningún escenario clínico

RESUMEN: COVID-19

La COVID-19 es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, el cual no debe confundirse con el SARS-CoV-1 responsable del antiguo síndrome respiratorio agudo severo. El espectro clínico de la infección es muy amplio, abarcando desde pacientes completamente asintomáticos hasta aquellos que cursan con un síndrome de dificultad respiratoria severa con neumonía o neumonitis viral. Los principales factores de riesgo para una evolución grave son la edad avanzada y los factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus y antecedentes de patología cardiovascular. También se incluyen pacientes con patología respiratoria o cardíaca previa que se descompensan fácilmente con la infección. El tratamiento depende de la gravedad del cuadro. En pacientes asintomáticos no se requiere intervención. En casos de infección respiratoria alta leve o síndrome gripal, el manejo es sintomático con paracetamol como fármaco de elección. En neumonías graves, el manejo incluye soporte, heparina de bajo peso molecular para prevención de trombosis, corticoides (que han demostrado disminuir significativamente la mortalidad) y antivirales específicos. El diagnóstico de elección es la PCR, con sensibilidad cercana al 90% y especificidad cercana al 100%. El test de antígeno es más rápido pero menos sensible, siendo más útil en pacientes sintomáticos. La TAC de tórax puede mostrar patrones característicos que eventualmente permiten el diagnóstico sin necesidad de otros exámenes. La prevención se basa en vacunación y medidas de control de contagio.